

校园用药生存课

# 合理用药

## 给宿舍药箱上堂课

会选药 · 看成分 · 避误区

苏州大学 | 选修课课堂展示

主讲：同学甲 / 同学乙

35 分钟 · 2 位讲者 · 4 部分



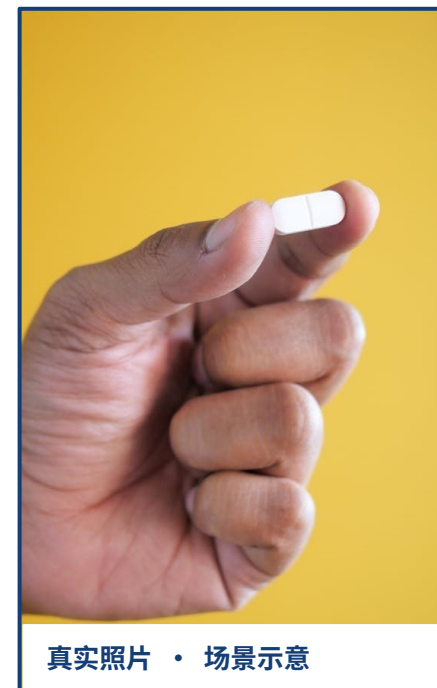
真实照片 · 场景示意

## 室友感冒了，你先做哪一步？

**A** 先吃室友推荐的两种感冒药

**B** 先看症状、成分和注意事项

**C** 先加一粒抗生素，求个安心



举手选择 A / B / C | 暂不揭晓

## 合理用药，要同时过四关

### 安全

关注禁忌与不良反应

### 有效

针对真正需要解决的问题

### 经济

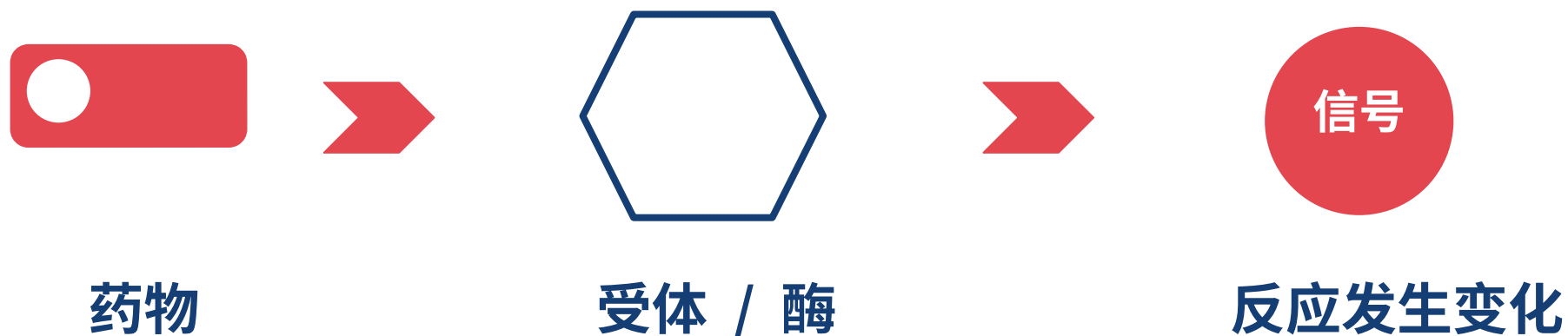
避免不必要的花费

### 适宜

适合这个人、这个时机

刚才选 B：先了解，再决定。

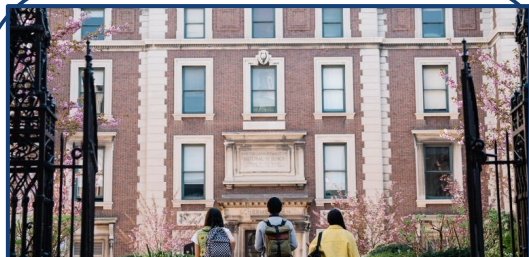
## 高中生物连接：药物也要找“靶点”



蛋白质的结构，与功能有关。

结构与功能有关 | 靶点也可能分布在多个部位

## 今天的路线：从会判断，到会行动



**01**

**基本原则**

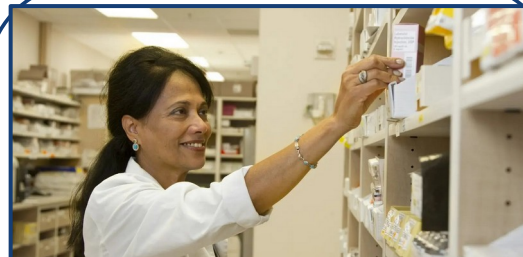
5 分钟



**02**

**宿舍误区**

17 分钟



**03**

**安全用药**

8 分钟



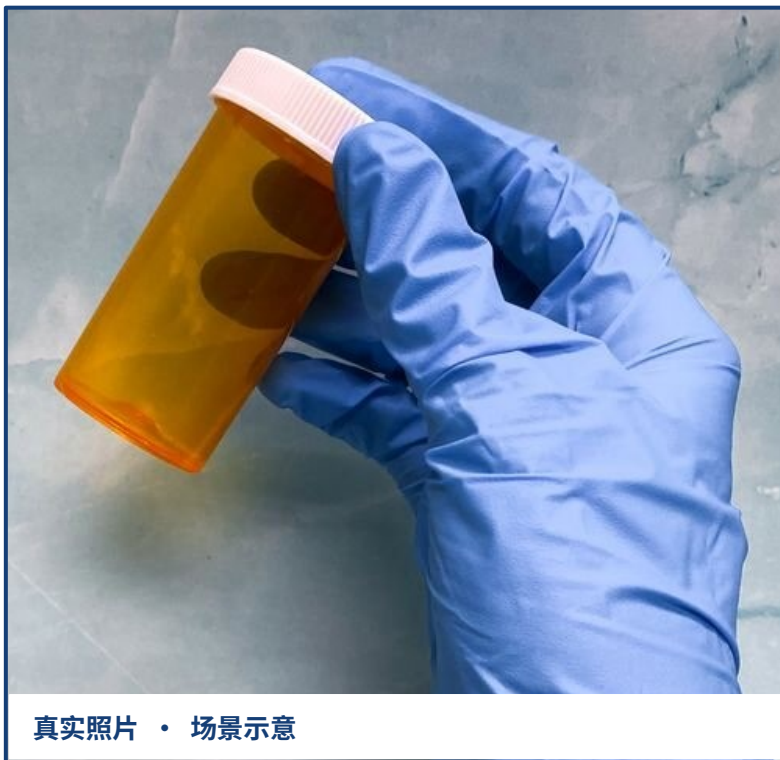
**04**

**选择挑战**

5 分钟

**全程约 35 分钟，已包含举手互动。**

## 案例①：两盒感冒药，真是“双保险”？



**小苏**

一盒治头痛，一盒治感冒

**室友**

名字不同，应该能一起吃？

**先暂停**

翻到“成分”一栏

**虚构情境 | 包装不同，成分可能重复。**

## 看成分，才能发现“隐形重复”

教学标签 A

有效成分

对乙酰氨基酚

教学标签 B

有效成分

对乙酰氨基酚

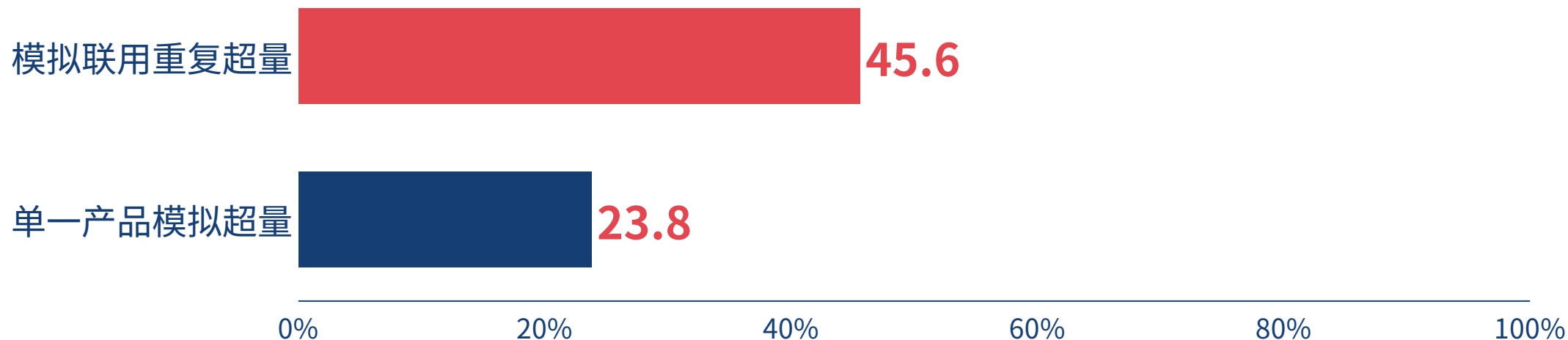
+其他成分

成分会汇合，风险不能按药盒“分开算”

通用名 / 成分优先于商品名 | 示意标签，不是实际说明书

## 真实研究：模拟用药，也容易出错

美国成人模拟任务 | n = 500 | 2012 年 | 单位： %



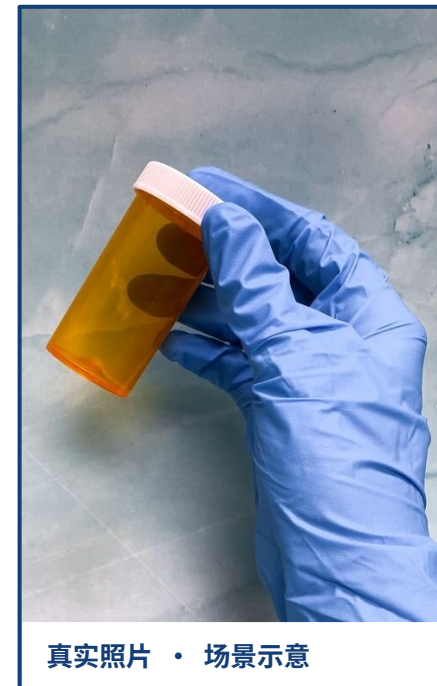
研究判断的是潜在超量风险，不是实际中毒事件。

**两项指标可能重叠，不能相加；不是实际中毒率。**



## 选择题②：两盒都含相同成分，怎么办？

- A** 商品名不同，可以照常同服
- B** 两种各减一半，自己调一调
- C** 暂不叠加，核对说明书并问药师



请选最稳妥的下一步 | 答案在下一页

## 答案 C：先核对，再决定

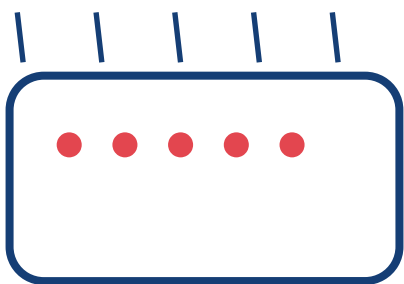
C

- 同成分：先不自行叠加
- 规格、时间、已服药物：一起核对
- 拿不准：带包装或照片问药师

---

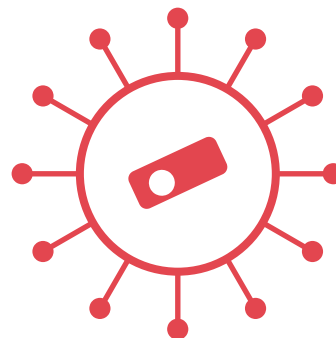
少猜一步，就少一个出错机会。

## 案例②：抗生素，不是感冒的通用答案



细菌

具有细胞结构  
细胞壁合成等可成为靶点

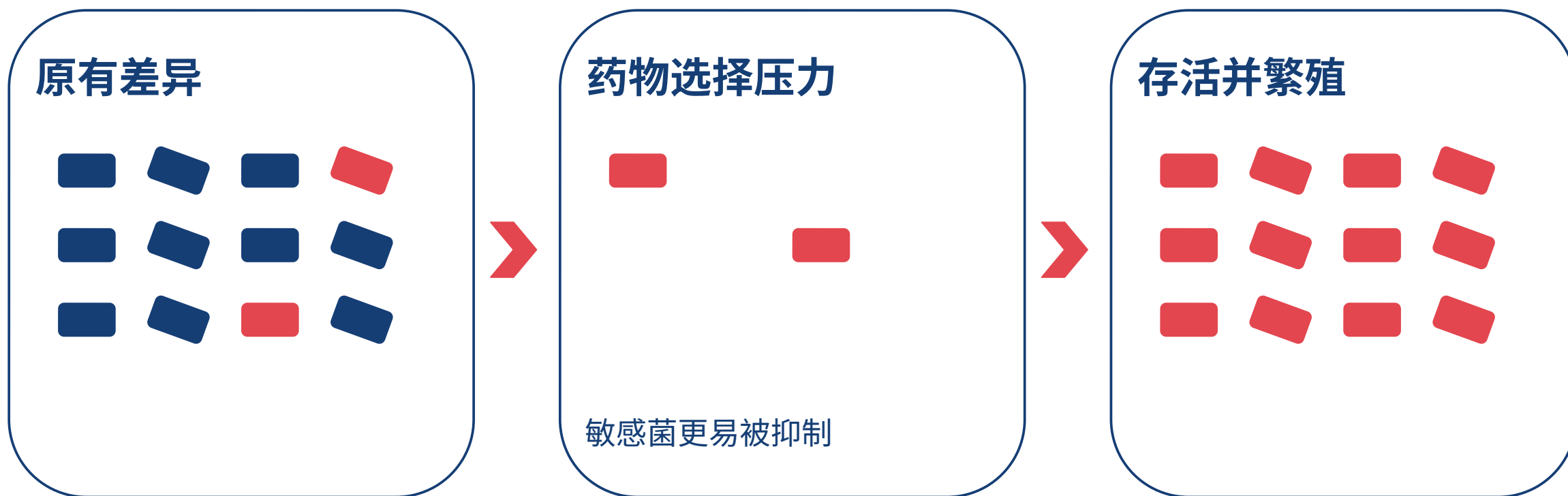


病毒

没有细胞结构  
抗生素不治疗普通感冒病毒

普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

## 耐药：被筛选出来的是细菌



蓝：敏感菌 红：耐药菌 | 数量仅为示意，不代表实验比例

连接高中生物：变异 + 选择 | 不是“人吃出了耐药体质”。

## 耐药风险，有多大？看清数据口径

2019 年全球细菌耐药负担 | 单位：万人 | 2022 年发表

### 相关死亡



区间：362—657

### 归因死亡



区间：91.1—171



细线表示 95% 不确定性区间

**2019 年全球估计 | 两种口径，不可相加。**

## 抗生素的三条行动规则



01

### 不自行启用

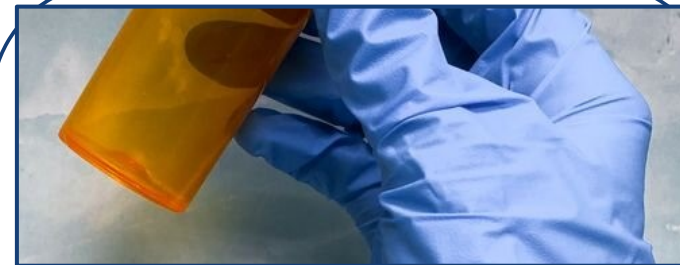
先明确是否需要



02

### 不分享剩药

相似症状不等于相同病因



03

### 按处方使用

不擅自停、加或延长

出现不良反应或疗效疑问，及时联系医生 / 药师。

## 案例③：“备考外挂”，真的值得试？



保健食品

不能代替药物治疗疾病

“提高考试成绩”

警惕夸大宣传

处方兴奋剂

不借药、不自行购买服用

清醒感，不等于学习效果的保证。

## 案例④：鼻子舒服了，上课却困了



真实照片 · 场景示意

部分抗组胺药

可能引起嗜睡

“较少嗜睡”

不代表人人都不困

困倦时

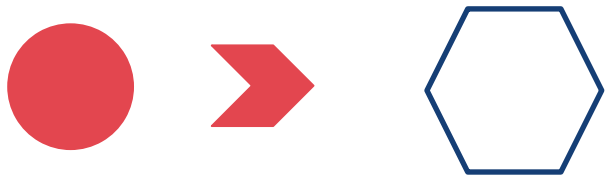
避免驾驶、骑车等高风险活动

不能仅凭“抗过敏药”四个字判断影响。



## 同一条信号，在不同部位有不同作用

外周组织



组胺信号 → 参与过敏症状

脑内

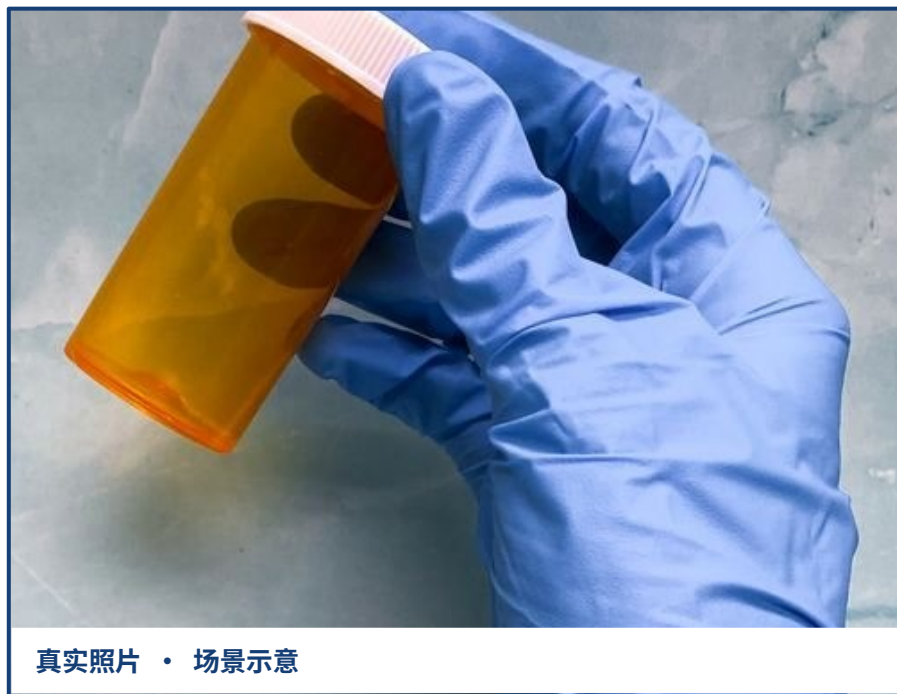


组胺信号 → 参与清醒状态

部分抗组胺药进入脑内后，可能引起嗜睡。

这是简化机制图；不能据此自行换药。

## 案例⑤：聚餐的酒，先缓一缓



**酒精 + 部分抗过敏药**

嗜睡与反应受损风险增加

**酒精 + 某些药物**

可能增加其他不良反应风险

**普通口服片剂 / 胶囊**

通常用白水，具体看说明书

**拿不准能否饮酒：先不喝，再查说明书或问药师。**

## 选择题③：聚餐前，选哪条路线？

A 已经吃过药，统一等两小时再喝酒

B 看具体药品要求；拿不准就先不喝

C 只要不醉，就不会与药物相互作用



**背景：今天服了抗过敏药，具体饮酒要求尚未确认。**

## 安全用药四步：看、核、问、记

**看**

症状、说明书、就医信号

**核**

成分、剂量、间隔、禁忌

**问**

医生 / 药师，确认不确定处

**记**

药名、时间、用量与反应

上一题选 B | 把“不确定”变成一个咨询动作。

## 说明书很长？先定位这六处

1

成分 / 通用名

2

适应证或功能主治

3

用法用量

4

禁忌与注意事项

5

相互作用 / 不良反应

6

贮藏条件 / 有效期



真实照片 · 场景示意

请以手中的真实说明书为准

六处是阅读起点，不代表其余内容可以跳过。

## 时间、剂量、剂型，都别凭感觉改



01

### 漏服

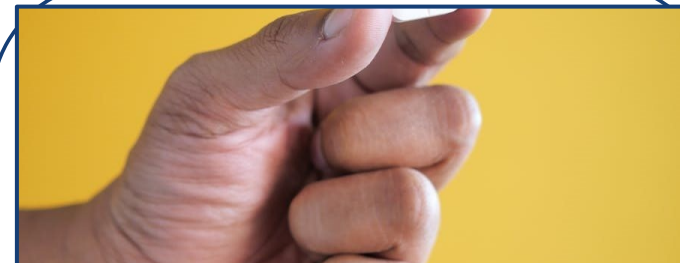
先查具体处理要求，不自行加倍



02

### 疗程

按处方执行，有问题及时咨询



03

### 剂型

缓释、肠溶等，不随意掰碎

不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

## 问药师时，把信息一次说清



真实照片 · 场景示意

- 我有什么症状，持续多久？
- 我正在吃什么，何时吃了多少？
- 我有哪些过敏史、疾病或特殊情况？

**带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。**

## 什么时候，不该继续自己试药？

120

严重急症  
立即求助

呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常

立即急救

疑似超量或误服

及时寻求医疗帮助

症状持续、加重或反复

及时就诊



真实照片 · 场景示意

严重急症拨打 120；带上药品信息，别等“自己好”。



## 宿舍药箱：留信息，也留秩序



- 原包装＋说明书 | 一起保留
- 有效期＋贮藏条件 | 定期检查
- 个人用药记录 | 不混装、不分享处方药

数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

## 把五个误区，换成五个动作

**01** 感冒药叠加



核对成分

**02** 感冒吃抗生素



先明确是否需要

**03** 备考“外挂”



不借用处方药

**04** 抗过敏后困倦



查提示、避风险活动

**05** 吃药后聚餐

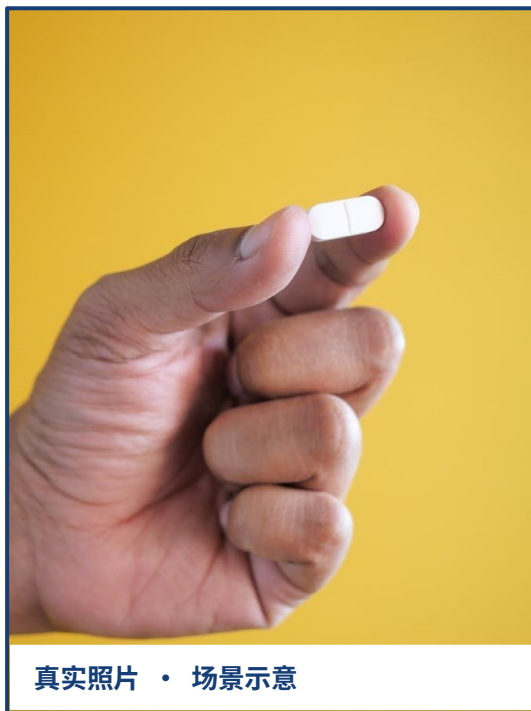


先确认饮酒要求

---

看、核、问、记：现在进入简单挑战。

## 综合挑战：小苏今晚怎么安排？



真实照片 · 场景示意

已服：一种复方感冒药

准备：再加一盒药＋参加聚餐

当前：成分没核对，症状尚轻

**虚构情境 | 无呼吸困难、意识异常等急症表现。**

## 你会替小苏选哪个方案？

**A** 两盒一起吃，聚餐少喝一点

**B** 先核对成分，拿不准问药师；先不喝酒

**C** 加抗生素预防一下，明天再看



单选 A / B / C | 想 10 秒，然后举手

## 答案 B：三个判断点，全都用上了

B

- 成分未核对 → 先不自行叠加
- 饮酒要求不明 → 先不喝，查询确认
- 没有用药依据 → 不自行加抗生素

---

若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

把判断带回生活

# 药可以常备， 判断不能省略。

先看说明书，再做用药决定  
核对重复成分，记录已服药物  
拿不准，问医生 / 药师

会看 · 会核 · 会问 · 会记



真实照片 · 场景示意

谢谢大家